

NURSING PROGRESS NOTES

JCI & HA Standardized Clinical Documentation

JCI COMPLIANT

PATIENT IDENTIFIER

[Patient A]

HN / AN

[HN-xxxx]

AGE / GENDER

65 ปี / ชาย

DATE / TIME

18 ก.ย. 2026 | 15:30 น.

SOBAP NURSING DOCUMENTATION

S - SUBJECTIVE DATA

ผู้ป่วยชาย อายุ 65 ปี แจ้งว่ามีอาการปวดแผลผ่าตัดบริเวณช่องท้องอย่างรุนแรง ระดับความปวด (Pain Score) เท่ากับ 8/10 ผู้ป่วยปฏิเสธการลุกเดินหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเนื่องจากกลัวความเจ็บปวด

O - OBJECTIVE DATA

BP
145/90

PR
98 bpm

RR
22 /min

SpO2
98%

Temp
37.2 °C

- Physical Exam:** นอนกระสับกระส่าย แสดงสีหน้าเจ็บปวด แผลผ่าตัดช่องท้องแห้งดี ไม่มีเลือดหรือสิ่งลื่นไหลซึมเลอะผ้าดาม
- Pain Assessment:** Pain Score = 8/10 (Severe Pain)
- Fall Risk Score:** High Risk (จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการได้รับยาระงับปวดกลุ่ม Opioids ร่วมกับภาวะปวดรุนแรง)

A - NURSING ASSESSMENT

- Acute post-operative pain:** ภาวะปวดเฉียบพลันหลังผ่าตัด สัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากการผ่าตัดช่องท้อง
- Impaired physical mobility:** การเคลื่อนไหวร่างกายลดลง สัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและความกลัวเจ็บแผล
- Risk for falls:** เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม สัมพันธ์กับการได้รับยาระงับปวดกลุ่ม Opioids

B - BARRIER TO CARE

ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลสูงและปฏิเสธการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัด (ปฏิเสธการลุกเดินและการไอขับเสมหะ) เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกระเทือนแผลผ่าตัด

P - NURSING PLAN & INTERVENTIONS

- บริหารยา Morphine 4 mg IV push ตามคำสั่งการรักษาของแพทย์
- ประเมินและบันทึกระดับความปวดซ้ำ (Pain Re-assessment) ภายใน 30 นาทีหลังได้รับยาทาง IV
- จัดท่านอนหัวสูง (Semi-Fowler's position) เพื่อลดความตึงรั้งบริเวณแผลผ่าตัดช่องท้อง
- แนะนำเทคนิคการใช้หมอนประคองแผลผ่าตัดขณะไอหรือเปลี่ยนท่า (Splinting technique)
- ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผลผ่าตัด (Dressing change) ด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ (Aseptic technique)
- เฝ้าระวังอาการข้างเคียงจาก Morphine (เช่น กดการหายใจ RR < 12 bpm, ความดันโลหิตต่ำ, ง่วงซึม)
- ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทั้ง 2 ข้าง ล็อกล้อเตียง และติดป้ายเตือน High Fall Risk

SAFETY & VERIFICATION CHECKLIST